Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008774-56.2021.8.21.0027/RS

AUTOR: THEREZINHA PAULETTO DRUZIAN

RÉU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

JANICE IZABEL DRUZIAN ajuizou *ação ordinária* em desfavor da **UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL** alegando ser portadora de *câncer* do tipo GLIOBASTOMA GRAU IV – CID 71, em estágio avançado. Argumentou que necessita do medicamento Avastin (Bevacizumabe) 10mg para o tratamento da doença, a cada 14 dias, conforme prescrito pelo seu médico-assistente. Afirmou que solicitou o medicamento à demandada e que, em função da negativa, necessitou custear a primeira sessão, ocorrida em 05/05/21, e que não possui condições financeiras de suportar as demais. Sustentou ser indevida a negativa da ré, sob o argumento de que não há cobertura contratual para o tratamento, haja vista que contratou o plano de saúde e paga rigorosamente as prestações correspondentes para obter amparo quando necessário. Defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ressaltando ser dever da ré garantir o tratamento à saúde adequado. Disse que a ausência de cobertura para medicamento não previsto no rol da ANS constitui abusividade que fere a dignidade da pessoa humana e outros princípios previstos na Constituição Federal. Pediu, então, a concessão da tutela de urgência para ser fornecida em todo o seu tratamento, a partir da próxima sessão, agendada para o dia 19/05/21, a medicação AVASTIN (BAVACIZUMABE) ou, alternativamente, que seja liberado o valor do medicamento. Requereu, ademais, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, pediu a procedência da ação para confirmar a tutela de urgência, bem como para condenar a ré a ressarcir integralmente o valor correspondente à primeira aplicação da medicação. Juntou documentos.

Foi concedida a antecipação de tutela (evento 4.1).

Indeferida a gratuidade judiciária (evento 9.1), a parte autora recolheu as custas iniciais (evento 12.2).

Sobreveio manifestação da ré informando o cumprimento da liminar deferida (evento 31.1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 36.1) requerendo, preliminarmente, a realização de consulta junto ao NAT-JUS, conforme Provimento n. 84/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça. Impugnou, ademais, o valor atribuído à causa, sob o argumento de que a obrigação de fazer, no caso, não possui um valor certo. No mérito, destacou a ausência de cobertura para medicamento de uso experimental (*off-label*), salientando que o fármaco não possui padrão específico para a patologia da autora. Sustentou ser lícita a exclusão de cobertura, pois há previsão regulamentar da ANS nesse sentido e cláusula expressa no contrato celebrado pelas partes. Refutou a alegada abusividade, pois a restrição não coloca o consumidor em desvantagem exagerada, apenas descreve hipóteses de não cobertura do contrato. Teceu considerações acerca do entendimento exarado pelo STJ no REsp 1733013/PR no tocante à ausência de cobertura para medicamento fora do Rol da ANS, reiterando a existência de previsão específica também nesse sentido nas condições gerais do contrato. Insurgiu-se quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, alegando a inexistência de verossimilhança entre o pedido e as provas apresentadas. Defendeu que, em caso de eventual procedência, o montante a ser ressarcido deve ser acrescido de juros somente a contar da citação válida no processo e correção monetária desde o ajuizamento da ação, conforme previsões do Código Civil. Pediu, por fim, a retificação do valor da causa para o montante pleiteado a título de reembolso e a improcedência da ação. Juntou documentos.

Em sede de réplica (evento 41.1), a autora informou o cumprimento da tutela de urgência deferida, ressalvando as duas primeiras aplicações, com as quais despendeu o montante integral de R$ 27.121,12. Refutou a necessidade de utilização de consulta ao núcleo de apoio técnico do Judiciário, argumentando tratar-se de mera faculdade do Magistrado. Sustentou estar correto o valor atribuído à causa, pois correspondente ao montante que seria despendido caso necessitasse utilizar recursos próprios para a realização do tratamento. No mérito, ressaltou ser atribuição do médico escolher o tratamento adequado ao paciente, destacando que não cabe à operadora do plano de saúde se recusar a custear o medicamento que lhe foi prescrito. Reiterou, por fim, o pedido de procedência da ação.

Sobreveio nova manifestação da autora (evento 45.1) postulando a suspensão do fornecimento do medicamento, em razão da impossibilidade de dar prosseguimento ao tratamento, por estar em estado terminal.

Oportunizada às partes a produção de outras provas, a ré manifestou-se (evento 51.1) informando o cancelamento do contrato em virtude do falecimento da autora.

O procurador da parte autora manifestou-se também informando o óbito e postulando a suspensão do processo (evento 52.1).

Foi deferida a suspensão do processo por 60 dias para fins de habilitação da mãe da *de cujus* (evento 54.1), o que foi realizado no evento 61.1.

Foi deferida a habilitação e determinada a inclusão da sucessora no polo ativo, em substituição à falecida (evento 68.1).

A ré manifestou-se postulando o julgamento antecipado do feito (evento 77.1.

Relatei.

Decido.

Trata-se de ação em que a autora pretendia cominar à ré a obrigação de fazer consistente em custear medicamento indicado por seu médico no tratamento de *câncer* do tipo GLIOBASTOMA GRAU IV – CID 71. Diante do seu falecimento, foi suspenso o cumprimento da liminar inicialmente deferida e habilitada a sucessão, na pessoa de sua mãe, THEREZINHA PAULETTO DRUZIAN.

Inicio destacando que, não obstante o pedido de remessa do processo ao NAT-JUS, formulado pela ré, não tenha sido previamente apreciado, tal fato não prejudica o julgamento do feito, haja vista que se trata de solicitação facultativa, inexistindo obrigatoriedade na remessa. Ademais, certo é que o médico que acompanha o estado do paciente é quem realmente possui condições de avaliar o seu estado clínico e o tratamento mais adequado à hipótese. Nesse sentido, também, o entendimento jurisprudencial:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA EM PARTE. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO NAT-JUS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ISOIMUNIZAÇÃO NA GESTAÇÃO. IMUNOGLOBULINA HUMANA. APLICAÇÃO EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FÁRMACO DE USO OFF LABEL. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. PREVENÇÃO A ABORTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO [...]* ***2. RELATIVAMENTE AO PLEITO DE NECESSIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO POR MÉDICOS DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO (NAT-JUS), CABE SALIENTAR QUE AS NORMAS CONSTANTES NO PROVIMENTO Nº 84/2019 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE DISPÕE SOBRE O USO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PARECERES E NOTAS TÉCNICAS, APENAS CONFEREM A POSSIBILIDADE AOS MAGISTRADOS DE SOLICITAREM APOIO TÉCNICO, NÃO HAVENDO OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO À ANÁLISE TÉCNICA DO NAT-JUS****. 3. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 4. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 5. CASO DOS AUTOS EM QUE O FÁRMACO POSTULADO NÃO CONSISTE EM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, PORQUANTO HÁ DOCUMENTO FIRMADO PELA MÉDICA ASSISTENTE QUE REFERE SER NECESSÁRIA A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA O TRATAMENTO EM QUESTÃO, RAZÃO PELA QUAL REPUTA-SE DESCABIDA A NEGATIVA SOB TAL PRETEXTO. 6. AINDA, O FATO DE O MEDICAMENTO PLEITEADO NÃO ESTAR PREVISTO NO ROL DA ANS PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A AUTORA NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA, MORMENTE CONSIDERANDO QUE HÁ EXPRESSA PREVISÃO DE COBERTURA PARA O FÁRMACO NO REFERIDO ROL, ASSOCIADO À INDICAÇÃO DA MÉDICA QUE ACOMPANHA A DEMANDANTE QUE APONTA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO COM URGÊNCIA, INDICANDO QUE A AUTORA JÁ "TEVE ABORTO E FETO MORTO A TERMO EM GESTAÇÃO ANTERIOR". 7. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, AFIGURA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO POSTULADO E DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR IMPRESCINDÍVEL PARA PERFECTIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. 8. PREZANDO-SE PELA OBSERVÂNCIA DO QUE PRECONIZAM OS VETORES DISPOSTOS NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, DEVEM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SER MINORADOS NO PRESENTE CASO. NÃO OBSTANTE, DEVE PREVALECER O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 6º-A DO ART. 85 DA CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO(Apelação Cível, Nº 50001378120188210105, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 29-03-2023)*

Pende de análise, também, a impugnação ao valor da causa suscitada pela parte ré.

Verifico, de pronto, contudo, que é caso de rejeitá-la, uma vez que, conforme esclarecido pela autora em sede de réplica, o montante indicado corresponde ao custo do tratamento cuja cobertura se pretende - e, por conseguinte, ao que seria despendido em caso de improcedência da ação.

Assim, o valor da causa equivale efetivamente ao proveito econômico que se pretende obter, atendendendo ao disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual **rejeito a preliminar**.

Adentrando o mérito, necessário salientar que, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidem, na relação discutida nos autos, as regras e princípios presentes no referido diploma legal, na medida em que a parte demandada prestou à autora os serviços que disponibiliza no mercado e a autora os utilizou, de fato, como destinatária final. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na súmula 469, que prevê expressamente que "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde*".

Restou incontroverso que à autora foi negada a cobertura para custeio de medicamento de uso contínuo indicado por seu médico como necessário para tratamento. A parte ré sustentou, na contestação, que a negativa deu-se em razão de que o medicamento pleiteado é de uso experimental, não sendo padronizado para o tumor que acometeu a autora. Disse, ainda, que há previsão contratual expressa de exclusão de cobertura, e que a ANS ampara essa exclusão, conforme artigo 20 da RN 428/2017:

> *Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.*
>
> *§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:*
>
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:*
>
> *a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;*
>
> *b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; ou*

c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no art. 26;

A ré também sustentou a ausência de cobertura para medicamento fora do Rol da ANS, destacando que, segundo recente entendimento do STJ, trata-se de rol taxativo.

Pois bem. No caso dos autos, não há dúvida de que a doença que afligiu a parte autora está coberta pelo plano de saúde, até porque a ré não nega tal afirmação. Também é certo que o medicamento postulado era essencial para o tratamento da doença, em razão de a paciente apresentar quadro sintomático e necessitar de resposta rápida (evento 1.8). Está justificada a escolha, inclusive, em protocolo clínico previsto no Manual de Oncologia Clínica do Brasil - MOC 2021, anexado pelo médico ao atestado e demonstrada a regressão da doença - ainda que de forma momentânea - após o uso (evento 29.5).

Como se vê, a defesa da parte ré utiliza-se dos argumentos de que **a)** o medicamento tem indicação *off label*, ou seja, de uso não aprovado; **b)** o contrato celebrado pelas partes não prevê cobertura para medicamento fora do rol da ANS.

Ocorre que o fato de se tratar de medicamento experimental não é suficiente para servir de justificativa para negativa de medicamento e/ou tratamento para doença que tem cobertura pelo plano de saúde, como já referido na decisão inicial. Até porque o medicamento possui registro no Brasil, apenas não há, ao menos por ora, indicação específica para a patologia da autora.

Ademais, em que pese Superior Tribunal de Justiça tenha entendido, recentemente, que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, de modo que as operadoras de plano de saúde não estariam, de fato, obrigadas a oferecer cobertura a tratamentos não previstos na lista (REsp 1.733.013, indicado na defesa) não é suficiente para amparar a negativa da ré. Isso porque a decisão não transitou em julgado até o momento e não possui caráter vinculante, em razão de não ter sido proferida por meio do rito dos recursos repetitivos.

De acordo com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, ademais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor. Também, o artigo 51 da legislação consumerista, no inciso IV, prevê a abusividade de cláusulas que estabeleçam "*obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade*". O parágrafo 1º do mencionado dispositivo, por sua vez, no inciso II, estabelece ser presumidamente exagerada a vantagem quando a norma restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal sorte que possa ameaçar o objeto ou o equilíbrio contratual.

Assim, diferentemente do que defendeu a ré, é evidente que a cláusula contratual contendo limitações genéricas é manifestamente abusiva, uma vez que, além de onerar o consumidor excessivamente, prejudica o fim ao qual se destina o contrato, que é a prestação de serviços de assistência à saúde, violando o disposto no artigo acima referido.

Vale destacar, nesse ponto, que a situação narrada nos autos sequer se amolda à previsão contratual de exclusão, em que previsto que o tratamento experimental é aquele que utiliza medicamentos não registrados no país ou que são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina:

TÍTULO IV – EXCLUSÕES DE COBERTURA

Art. 23. Estão excluídos da cobertura deste plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a segmentação assistencial contratada, ou sem a observância das diretrizes de utilização, bem como:
I - atendimentos prestados **antes do início da vigência contratual** ou do cumprimento dos **prazos de carências**, ou prestados em **desacordo** com o estabelecido neste contrato;

II - tratamento clínico ou cirúrgico **experimental**, isto é, aqueles que:
a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;
b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia- CFO; ou

Com efeito, **os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência que pertence ao profissional médico que assiste o paciente, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.** No mesmo sentido, aliás, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO EC IV COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA METASTÁTICA ÓSSEA E PULMONAR. MEDICAMENTO ATEZOLIZUMABE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. I. DE ACORDO COM A REDAÇÃO DO ART. 300, CAPUT, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. II. NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA POSTULADA. ACONTECE QUE OS DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS NO EVENTO 1 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS DEMONSTRAM QUE A AUTORA, ORA AGRAVADA, FOI DIAGNOSTICADA COM ADENOCARCINOMA DE PULMÃO EC IV COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA METASTÁTICA ÓSSEA E PULMONAR, SENDO INDICADO O TRATAMENTO COM TRATAMENTO COM CARBOPLATINA AUC 6, PACLITAXEL 175MG/M², BEVACIZUMABE 15 MG/KG E ATEZOLIZUMABE 1200 MG, INTRAVENOSO, A CADA 21 DIAS POR 6 CICLOS, SEGUIDO DE MANUTENÇÃO COM BEVACIZUMABE 15 MG/KG E ATEZOLIZUMABE 1200 MG, INTRAVENOSO, A CADA 21 DIAS POR TEMPO INDETERMINADO (ATÉ REGRESSÃO DA NEOPLASIA).* ***III. ADEMAIS, O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE FRACA NA RELAÇÃO, NA FORMA ART. 47, DO ALUDIDO DIPLOMA. IV. DA MESMA FORMA, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO EM ROL DA ANS, O QUAL CONSTITUI APENAS REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA, CONFORME § 12 DO ART. 10 DA LEI N° 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI N° 14.454/2022, NÃO SENDO, PORTANTO, TAXATIVO. V. AFORA ISSO, QUANDO UM MEDICAMENTO É APROVADO PARA UMA DETERMINADA INDICAÇÃO, NÃO SIGNIFICA QUE ESTA SEJA A ÚNICA POSSÍVEL. ALIÁS, NA MAIORIA DAS VEZES, O USO OFF LABEL DE UM MEDICAMENTO PODE SER ESSENCIALMENTE NECESSÁRIO E CORRETO PARA OUTRAS DOENÇAS, DEPENDENDO TÃO-SOMENTE DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE.*** *VI. PORTANTO, SE HOUVE INDICAÇÃO DO TRATAMENTO POSTULADO, DESCABE, PELO MENOS NESTE*

MOMENTO, AO INÍCIO DA LIDE, EVENTUAL NEGATIVA DE COBERTURA, O QUE PODE CAUSAR PREJUÍZO IRREPARÁVEL À SAÚDE E À VIDA DA AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51499269120228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-11-2022)

Assim, é descabida a negativa da parte ré, pois o que importa para solução do litígio é a existência de cobertura para a doença apresentada, independentemente do local em que este deverá ser ministrado.

Portanto, ainda que o pedido de obrigação de fazer não tenha mais objeto, em razão do falecimento da autora, impositiva a procedência da ação para confirmar a liminar inicialmente deferida e acolher o pedido de reembolso dos valores comprovadamente despendidos (1.12 e 19.2) até o cumprimento da decisão. As despesas deverão ser acrescidas de correção monetária pelo IGP-M a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Registro, nesse ponto, ser incabível a incidência da multa diária no caso concreto, pois a contagem do prazo para cumprimento da liminar inicia somente a partir da efetiva intimação judicial, que ocorreu após a realização da segunda aplicação.

Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **THEREZINHA PAULETTO DRUZIAN** em desfavor de **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL** para, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, **confirmar** a liminar inicialmente deferida - até a data do falecimento da beneficiária - e **condenar** a ré a restituir à sucessora o montante total de R$ 27.121,12, correspondente às duas aplicações iniciais do medicamento, que deverá ser corrigido pelo IGP-M, individualmente, a contar de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A demandada arcará com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sentença publicada pelo lançamento de documento digital no sistema E-proc. Desnecessário o registro, intimem-se.

Sobrevindo recurso(s) de embargos de declaração, venham conclusos os autos para análise dos pressupostos recursais e eventual necessidade de garantir-se o contraditório.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) apelada(s) para, em quinze dias, apresentar(em) contrarrazões. Caso haja recurso adesivo ou suscitação de questões preliminares (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil) em contrarrazões, dê-se vista ao(s) apelante(s) por novos quinze dias, para manifestação. Concluídas as intimações e decorridos os prazos, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por **TRAUDELI IUNG, Juíza de Direito**, em 30/5/2023, às 17:38:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10039102200v16** e o código CRC **a562a05a**.